

03 - 04- Trouble Obsessionnel Compulsif - Pr. Laffinti

Pour continuer les chapitres qu'on a commencé la dernière fois, il nous reste deux chapitres qu'on va aborder aujourd'hui. Le premier, c'est le trouble obsessionnel compulsif, un trouble où l'anxiété aussi est un symptôme cardinal et qui faisait d'ailleurs partie des troubles anxieux. Pour définir le trouble obsessionnel compulsif, c'est un trouble qui se caractérise par des pensées qui sont intrusives, qui sont répétitives, parfois stéréotypées, qu'on appelle obsession, ou par des comportements que le sujet se sent obligé d'exécuter, se sent contraint de faire, appelés compulsions, ou les deux à la fois.

Ces compulsions et ces obsessions sont à l'origine d'une gêne considérable pour le sujet sur le plan personnel, professionnel et social. C'est une pathologie qui est fréquente, mais qui est souvent méconnue pendant plusieurs années, méconnue parce que les patients ne savent pas qu'il s'agit de quelque chose de pathologique ou de malade, et même quand ils reconnaissent le caractère pathologique, ils ont du mal à consulter avec un retard diagnostique qui peut aller à plusieurs années. C'est un trouble dont les formes complexes, sévères, peuvent être très invalidantes, très gênantes pour la personne qui en souffre.

Comme je citais auparavant, c'est un trouble qui faisait partie des troubles anxieux, mais dans les classifications actuelles, que ce soit dans le DSM-5 ou la CM-11, la dernière version, c'est un trouble qui fait désormais une catégorie à part entière appelée trouble obsessionnel compulsif et apparenté. Donc ça ne fait plus partie des troubles anxieux. Sur le plan épidémiologique, j'ai dit que c'est une pathologie assez fréquente, avec une prévalence sur une vie qui peut aller jusqu'à 3%.

C'est l'une des rares pathologies psychiatriques où le sexe ratio est égal à 1, donc il touche aussi bien les femmes que les hommes à titre égal. On a vu que pour les autres troubles anxieux, c'est toujours une prédominance féminine. C'est une pathologie qui peut commencer très tôt, souvent.

Souvent, elle commence très tôt, dès la petite enfance, avec plus de deux tiers des cas avant l'âge de 25 ans. Avec un début qui est généralement plus précoce chez l'homme que chez le garçon par rapport à la fille. Une pathologie aussi qui expose à beaucoup de comorbidités, que ce soit psychiatriques ou autres, notamment des comptes de compensation dépressives, le recours à l'abus de substances.

C'est un délai moyen qui peut aller jusqu'à 12 ans avant le début d'une prise en charge. C'est-à-dire que c'est une pathologie qui reste très longtemps méconnue ou cachée, ou en tout cas non diagnostiquée. Pour l'étude clinique, le début de la pathologie peut être d'installation rapide, aiguë ou subaiguë, généralement suite à des facteurs précipitants, comme une mort ou une maladie grave.

Mais le plus souvent, c'est quelque chose qui a un rapport avec la notion de responsabilité, soit le

changement de statut marital, donc quelqu'un qui vient de se marier, ou qui vient d'avoir un enfant, donc le statut de paternité ou de mère, ou le fait d'avoir une nouvelle responsabilité, un nouveau poste dans le travail. En tout cas, cette question de responsabilité est souvent soulevée dans le déclenchement du trouble. Mais le plus souvent, le trouble commence dès un âge très jeune, et ça commence progressivement, et on a des enfants qui ont déjà un tableau constitué de troubles obstinationnels compulsifs.

Donc c'est souvent une installation progressive depuis l'enfance, et qui peut s'aggraver par la suite dans des circonstances un peu particulières. Donc la clinique du trouble, je rejoins la définition, je rejoins le nom, trouble obsessionnel compulsif, donc la clinique, c'est fait d'obsessions et ou de compulsions qui ont le caractère d'être répétitifs et récurrents, et qui sont pénibles, parfois très invalidants. Donc tout d'abord, on commence par les obsessions.

C'est quoi les obsessions? Les obsessions, ça peut correspondre à une idée, ou à une pensée, une représentation mentale, parfois une idée impulsive, qui a ce caractère d'être répétitif, d'être intrusive dans l'esprit de la personne, malgré elle, qui va s'imposer à son esprit, qui va la siéger, donc ne laissant pas repos, malgré les efforts de lutte, on parle de ces idées, ces images, ces représentations intrusives, va créer une angoisse importante chez la personne, de telle sorte qu'il va essayer de lutter contre ces angoisses, qu'on appelle une lutte anxieuse, mais malgré cette lutte, malgré cette lutte anxieuse, la personne n'arrive pas à les chasser. Donc ça part et ça revient, ça revient en permanence avec ce caractère intrusif. Donc la personne reconnaît que ces images, ces pensées obsédantes, obsessionnelles, émanent de sa propre activité psychique, donc ce n'est pas quelque chose qui est imposé de l'extérieur, par une force extérieure, comme dans le cas de Chéchele Delirant, qui dit que c'est des voix ou des pensées imposées par d'autres.

Là, la personne reconnaît que c'est le produit de sa propre activité psychique, de son propre esprit, mais généralement ce sont des pensées qui sont en désaccord avec ses principes, ses convictions personnelles. Le plus souvent, c'est en contradiction avec ce que la personne pense réellement, d'où cette lutte anxieuse, d'où cet engagement de la personne pour essayer de les chasser, de les combattre. Pour les obsessions, ils sont distingués en trois types, les obsessions idéatives, les obsessions phobiques et les obsessions impulsives.

Pour les obsessions idéatives, selon l'indique, ce sont des idées, ça peut être des pensées, ça peut être aussi des images ou une représentation mentale qui va s'incruster dans l'esprit de la personne, qui va intoxiquer sa pensée de fait de sa répétition, de sa récurrence, de leur caractère intrusive, et dont la thématique peut être de toutes sortes. Les plus décrits, ce sont les thématiques religieuses, sexuelles, comme j'y dis souvent, en contradiction avec ce que la personne pense réellement. Par exemple, pour la thématique religieuse, l'idée qui vient par exemple à la personne, c'est qu'une idée sur le doute de l'existence de Dieu ou quelque chose de ce genre, et la personne essaie de lutter contre cette pensée, cette idée, parce que ça ne correspond pas à lui, ça ne correspond pas à ses convictions, à ses principes, mais malgré cette

lutte, l'idée va s'imposer et revenir à chaque fois.

On parle d'idées égo-dystoniques, c'est-à-dire en contradiction avec ce que la personne pense. Ça peut aussi être des thèmes relatifs à la sexualité. Très souvent on retrouve chez les patients cette thématique sexuelle qui revient à chaque fois.

Par exemple, je vous dis des exemples concrets, j'ai un collègue médecin, chez lui l'idée qui vient à chaque fois c'est qu'il est homosexuel. L'idée est née du fait qu'il est arrivé à un certain âge et n'est pas encore marié, et de là est venue cette idée qu'on croit que les gens pensent qu'il est homosexuel. Ce n'est pas une simple idée qui vient et qui part, mais c'est tellement insistant, intrusif et répétitif qu'il rend la personne mal à l'aise, et des fois pour d'autres idées la personne devient presque, va croire à cette idée.

Ça peut aussi être une image qui est souvent obscène ou que la personne ne veut pas voir. Par exemple, il voit une scène sexuelle qui concerne sa maman, son père, sa soeur ou son épouse. D'ailleurs, j'avais un patient aussi, l'image qui revient c'est de voir son épouse dans le bras d'un autre homme, c'est tellement répétitif, tellement intrusif qu'il commence à se douter de cette possibilité de relations extra-conjugales avec des conséquences fâcheuses sur leur vie conjugale.

Pour d'autres, toujours dans la thématique sexuelle, un autre patient qui pour lui, l'idée qui vient c'est que dès que c'est un militaire qui travaille loin de chez lui, et dès qu'il est loin, il pense que sa maman, sa soeur et son épouse ont des relations sexuelles et qu'il profite de son absence pour avoir des rapports avec des étrangers. C'est tellement insistant qu'il donne une véritable souffrance psychique pour ces patients. L'idée peut être de contenu neutre, indépendamment de la thématique religieuse, sexuelle, pétaphysique ou morale.

Ça peut être une idée neutre, mais ce caractère répétitif, intrusif peut générer de l'anxiété et de l'angoisse. Il y a plusieurs exemples, j'ai donné des exemples d'obsessions-idées, mais il y a aussi des obsessions-doutes. Le doute, c'est un doute par rapport à l'exécution au nom d'une tâche.

C'est une personne qui va se douter de la fermeture de la porte de la maison le soir, ou de la fermeture du gaz, ou d'éteindre l'électricité, ou débrancher un appareil électrique, ou le doute sur le fait d'avoir accompli une tâche. J'avais un patient qui, l'idée qui vient, quand il est sur le trajet, un patient militaire qui est sur le trajet pour son travail, des fois l'idée qui vient c'est qu'il a peut-être heurté quelqu'un sur le trajet. L'idée revient de telle sorte qu'il fait des comportements pour vérifier s'il s'est produit ou pas.

Ces comportements, ce sont les conclusions qu'on va voir plus tard. Ça peut aussi être des obsessions sur le scrupule, des remords ou des ruminations par rapport à une faute parfois très minime, par rapport à un mot qui a été dit ou un geste qui a été fait dans le passé, qui n'a pas

forcément une grande importance, mais les ruminations reviennent à chaque fois de façon incessante et angoissante. Ça concerne les obsessions idéatives.

Pour le deuxième type, ce sont les obsessions phobiques. Comme vous l'observez, il y a le mot phobie qui revient, qui dit phobie, une crainte, une peur pathologique. Ça ne fait pas partie des phobies qu'on a traitées la dernière fois.

C'est un type d'obsession. La différence, c'est que là, c'est une crainte qui va avoir ce caractère répétitif, intrusif, obsédant, en l'absence même de l'objet ou de la situation qui d'habitude génère l'anxiété. Dans la phobie qu'on a vue la dernière fois, par exemple la phobie du vent ou d'un animal, cette angoisse se déclenche avec l'exposition à cet animal ou à cet objet phobogène.

Par exemple, dans l'anxiété sociale, c'est la situation d'interaction sociale qui génère cette anxiété. Là, c'est une anxiété, c'est une crainte obsédante qui revient même en dehors de cette situation sociale, en dehors de l'exposition de cet objet. Rien que le fait d'y penser ou de l'évoquer peut générer cette crainte et cette obsession.

Donc, quelques exemples, c'est la peur du couteau, la peur aussi d'attraper une maladie. Par exemple, la peur de tomber malade d'un cancer ou d'avoir le sida par la suite. C'est une peur qui génère l'anxiété, l'angoisse importante chaque fois que ces sujets sont abordés ou chaque fois qu'ils passent dans l'esprit de ces gens.

Les personnes savent que c'est insensé, c'est absurde, c'est bizarre, mais malgré ça, ils n'arrivent pas à chasser ou à combattre ces idées qui reviennent à chaque fois. Bien sûr, cette crainte obsédante de ces sujets, de ces situations, va pousser la personne à exécuter certains actes ou à éviter certains endroits. Ce sont les compulsions qu'on va traiter plus tard.

Pour le troisième type d'obsession, ce sont les obsessions impulsives ou appelées aussi phobies d'impulsion. Là aussi, le mot phobie revient parce qu'il y a toujours cette crainte obsédante, répétitive et intrusive. L'objet de la crainte, c'est le fait de commettre un acte scandaleux ou dangereux ou ridicule contre sa volonté.

La personne craint de perdre le contrôle de soi-même et de passer à l'acte et faire un acte dangereux, ridicule ou scandaleux. À la différence par rapport à la phobie sociale, où là aussi il y a une crainte d'agir de façon émulante devant autrui, par peur de jugement de l'autre, par manque de confiance en soi, là, la crainte, c'est de perdre le contrôle indépendamment d'une situation sociale. Rien qu'hier, j'ai reçu un patient qui a ce genre d'obsession.

Malheureusement, c'était la première consultation, il n'arrivait pas bien à exprimer ça. L'obsession impulsive qui est là, c'est d'étrangler des personnes qui sont à côté, des collègues, des membres de la famille ou même des inconnus. Perdre le contrôle et passer à l'acte.

L'idée qui vient, c'est qu'il peut, à un moment donné, passer à l'acte et étrangler une personne

étrangère. Tellement l'idée est présente et insistante que la personne croit réellement qu'il peut perdre le contrôle et passer à l'acte. C'est pour ça que ça génère une anxiété terrible.

Pour d'autres patients, un autre patient, l'idée qui lui venait, c'était la peur de la nuit, parce qu'il craint de perdre le contrôle pendant son sommeil et égorger ses enfants. Il était obligé à chaque fois, même quand l'idée était tellement présente, de demander à son épouse de fermer à clé. Il s'isole dans une chambre et demande à son épouse de fermer à clé, ou au moins fermer la cuisine à clé.

Tellement l'idée est présente et angoissante et répétitive que la personne a du mal à supporter. Généralement, fort heureusement, la personne ne passe pas à l'acte. Ça reste au niveau de son esprit, de son activité psychique, mais heureusement qu'il ne passe pas à l'acte.

L'idée peut être de toute nature. Des fois, il craint de pousser quelqu'un sous le métro, devant une voiture, ou d'écraser quelqu'un par sa voiture. Ce sont des idées de dire ou de prononcer des mots vulgaires, des mots déplacés, en plein public, en pleine réunion, par exemple, ou en plein amphithéâtre, de dire des choses obscènes, au sacrilège, qui portent atteinte à la pudeur.

C'est bon ? L'ensemble de ces obsessions, que ce soit des obsessions idéatives, phobiques ou impulsives, vont générer une anxiété tellement importante, avec une lutte anxieuse qui va pousser la personne, les sujets, à adopter parfois des comportements dont le but est de diminuer, d'atténuer cette anxiété générée par les obsessions. Ces comportements sont appelés compulsions. Les compulsions, ce sont des actes, ça peut être des comportements moteurs, mais ça peut être des actes mentaux, que la personne se sent obligée d'exécuter, contrainte d'accomplir, pour atténuer, pour diminuer cette anxiété liée aux obsessions.

C'est pour ça qu'on parle de cette valeur conjuratoire, pour conjurer cette angoisse en rapport avec les obsessions. Ce sont généralement des actes qui sont intentionnels. La personne sait ce qu'elle fait, elle sait que c'est un acte absurde, des fois qui n'est pas en rapport, qui est en décalage avec l'idée obsédante qu'elle a générée, mais malgré ça, elle ne peut pas s'empêcher d'accomplir.

Des fois, ces actes et ces compulsions sont exécutés avec certaines règles très strictes, très drastiques, qui feront que la personne, s'il fait une simple erreur ou s'il ne fait pas les choses comme elle a l'habitude de faire, elle est obligée des fois de refaire tout dès le début. Là aussi, ça peut répondre à l'obsession qui les a générées. Par exemple, pour les personnes qui ont des obsessions, des doutes sur le fait d'avoir accompli ou pas, ça va être des actes compulsifs de vérification.

La personne qui a des doutes sur la fermeture de la porte, elle va aller vérifier si la porte est bien fermée. Elle va trouver que la porte est fermée, elle va revenir, par exemple, dormir, et là, l'idée revient de façon insistante que le doute va recommencer, et il va aller une deuxième fois, une troisième, une quatrième fois, plusieurs fois pour vérifier la fermeture de porte ou la fermeture de

gaz. Pour la personne que j'ai citée tout à l'heure, qui a ce doute d'avoir heurté quelqu'un sur la voie, sur le trajet pour son travail, des fois, il revient deux, trois fois pour faire tout le trajet de là où l'idée est venue jusqu'à chez lui pour s'assurer qu'effectivement, il n'y a personne sur la route, il n'y a pas de foule, il n'y a pas de gens qui ont quelqu'un de blessé.

C'est bien passionnant parce qu'il faut comprendre que, là, j'ai donné plusieurs exemples, mais une personne peut avoir plusieurs types d'obsessions. Elle peut avoir à la fois des obsessions idéatives, phobiques et impulsives, et des compulsions à la fois. Pour les formes complexes et sévères, les personnes peuvent avoir plusieurs types d'obsessions et de compulsions à la fois.

Pour donner des exemples concrets, pour voir l'ampleur de la pathologie, une fois, chez l'épicier du coin, il y avait une femme juste à côté, et l'idée impulsive qui est venue chez lui, c'est que peut-être qu'il va perdre le contrôle et toucher la femme dans ses parties intimes ou dans ses fesses. À un moment donné, elle avait cette idée de perdre le contrôle et de passer à l'acte. Après, c'est l'idée doute par rapport au fait d'avoir un complice.

L'idée qui est venue quand il est parti chez lui, c'est que peut-être qu'il a perdu le contrôle et qu'il est réellement passé à l'acte et qu'il a touché. Et là, ce doute, ce remords et ces ruminations ont commencé. Donc, il était obligé de revenir chez l'épicier qu'il connaît et de lui demander de revoir les vidéos de surveillance pour s'assurer qu'il n'ait pas passé à l'acte, qu'il n'ait pas touché cette femme.

Le même patient, il me raconte qu'une fois, il a serré la main à un collègue à lui. Ce collègue était célibataire. C'est un militaire qui travaillait à Worcester.

Il avait des relations un peu chaotiques avec des prostituées. Donc, il l'a rencontré une fois, il lui a serré la main. Jusqu'à présent, tout va bien.

Juste après, un moment plus tard, le patient est allé faire pipi, uriner. Et au moment où il a touché son organe génital, c'est là où l'idée qui va venir que peut-être la personne qui a des reports par-ci, par-là, peut-être qu'elle est contaminée par une maladie sexuellement transmissible et peut-être qu'il lui a transmis la maladie puisqu'il a touché son organe génital. Donc, l'idée est venue tellement insistante qu'elle est partie se laver les mains et même son organe génital avec de l'eau de javel.

C'est-à-dire que l'idée est tellement insistante, tellement présente, tellement angoissante que la personne peut avoir des comportements de vérification, de lavage, d'arrangement pour les gens qui ont cette obsession d'ordre et de symétrie. Mais ça peut aussi être des simples calculs mentaux, ou le fait de répéter un certain mot, une phrase, ou faire une série de calculs, ce qu'on appelle une arithmomanie ou onomatomanie. C'est le fait de répéter un mot ou une phrase qui a cette valeur conjuratoire de l'angoisse.

C'est absurde. Une personne qui a une idée recédente sexuelle, religieuse ou autre va essayer

de répéter un certain mot ou faire un acte parfois absurde ou répéter une série de calculs juste pour lutter contre cette idée. Ces comportements compulsifs, quand ils deviennent plus présents, plus prégnants, ça peut évoluer selon leur propre compte indépendamment des obsessions.

Ça devient ce qu'on appelle le rituel. Ce sont des conclusions qui deviennent plus élaborées, plus complexes et que la personne va adopter ou faire indépendamment de l'idée obsédante. Par exemple, une personne qui a cette conclusion de rangement, qui va à chaque fois défaire et refaire son placard, ses armoires, même en l'absence de doute sur le désordre.

Même s'il n'y a pas de zéro, tout est en ordre, tout est nickel. Mais la personne ne peut pas s'empêcher de défaire et de refaire à chaque fois ou de se laver plusieurs fois la main pour éviter les rituels. Je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine que vous connaissez Raphaël Nadal, le joueur de tennis, vous le connaissez ? Si vous remarquez les petites pauses, c'est ces petits rituels concernant les bouteilles d'eau et de boisson.

À chaque fois, il essaie de les poser de la même manière, à une distance bien calculée. Des fois, il passe du temps à vouloir poser la bouteille dans la position exacte qu'il a l'habitude de faire. Pour les formes cliniques, c'est plus des regroupements de formes en fonction de l'obsession ou des compulsions les plus fréquentes.

On peut distinguer les laveurs, qui sont le plus souvent de femmes, qui vont avoir des rituels de lavage répétés avec peur de contamination, peur de la saleté, peur de la souillure. Ce sont des gens qui vont adopter des comportements d'évitement, par exemple de toucher les poignets ou mettre des gants. C'est ce qu'on a un peu vécu lors de la période du Covid-19.

On a eu presque tous ce genre de comportement, mais pour ces personnes, c'est dans la durée, c'est tellement angoissant, c'est astreignant et c'est difficile à vivre. Des fois, ce sont des femmes qui utilisent beaucoup de détergents, beaucoup de produits cosmétiques et qui, avec parfois même des raisons dermatologiques en conséquence. Des fois, on peut supposer le diagnostic dès que la patiente rentre en consultation, même en dehors de la psychiatrie.

Donc, des fois, dès que la patiente rentre, on peut supposer le diagnostic. Vous savez pourquoi? Avant de regarder les lésions, l'odeur de l'eau de Gervais, tellement ils l'utilisent de façon abusive et quand ils viennent, on dirait qu'on vient de verser de l'eau de Gervais dans la salle de consultation. Et bien sûr, avec les lésions dermatologiques aussi.

Pour les vérificateurs, ce sont surtout des hommes, donc l'idée, c'est de prévenir une catastrophe ou des conséquences fâcheuses. C'est l'exemple qu'on a vu avec la personne qui vérifiait si elle n'a pas heurté une personne ou l'autre patient qui vérifie que la cuisine ou la porte est fermée. Donc, les obsessions abusives, les ruminations, ce sont des personnes où les obsessions sont plus en rapport avec des remords et des idées de culpabilité qui reviennent par rapport à des images, par rapport à des pensées inacceptables sexuelles ou religieuses ou autres.

Et puis, l'obsession d'ordre de l'asymétrie, ce sont des gens qui ne supportent pas le désordre, qui ont une façon de ranger qui est toujours la même. Chaque fois qu'une personne ou par exemple un membre de la famille, un enfant, le mari ou le conjoint a déplacé ou a changé l'ordre que la personne concernée a fait au départ, ça angoisse, ça génère de l'anxiété et elle est obligée de ranger dès le début. Si vous avez des questions par rapport à la clinique, pour le diagnostic, il faut insister sur la recherche active.

Ce ne sont pas des symptômes qui sont exposés comme ça par le patient. Il faut aller chercher, il faut demander si le patient n'a pas des idées intrusives, n'a pas des comportements un peu répétés, des comportements de lavage, de vérification. Parce que pour certaines personnes, ce sont des comportements tout à fait normal.

Pour une femme qui se lave plusieurs fois, qui lave ses ustensiles de cuisine plusieurs fois, pour elle, ça fait partie d'un enfant, donc c'est tout à fait normal. Pareil pour quelqu'un qui range, qui veut que tout soit rangé. Des fois, ils ne savent pas que ça dépasse le caractère normal et que ça devient pathologique.

Même pour les gens qui commencent à se rendre compte que c'est exagéré, que c'est pathologique, que c'est normal, ils ont du mal à le dire, à l'exprimer. Des fois, c'est l'entourage qui va pousser la personne à consulter et à demander de l'aide, surtout quand l'entourage commence à en souffrir aussi. Parce que des femmes, par exemple, qui ont cette obsession de contamination, de sueur, ils vont imposer ces mesures drastiques de lavage à leurs enfants, et les pauvres, des fois, vont en souffrir.

Je vous donne l'exemple d'une femme que je suivais dans la ville de Golmim, qui a été poussée par son mari à aller consulter. Pourquoi ? Parce qu'il en a marre des factures élevées de l'eau, parce qu'il dépensait énormément d'eau dans ces lavages répétés. C'est le mari qui a poussé la femme à venir consulter.

Ce qui fait que le délai, comme on l'a cité au départ, c'est un délai assez lent avant la prise en charge, avant la rencontre avec le corps médical. Pour le diagnostic positif, là, j'ai résumé les critères diagnostiques du DSM. Le premier critère, c'est la présence d'obsession et ou de compulsion, soit obsession, soit compulsion ou les deux à la fois, qui sont à l'origine d'une perte considérable de temps.

C'est une condition que le DSM met aussi. Cette perte de temps est une notion importante. On parle généralement d'un minimum d'une heure par jour de perte de temps dans les vérifications, dans le rangement, dans son comportement obsessionnel ou compulsif.

Pour les autres critères, il faut que ça ne soit pas en lien avec d'autres pathologies psychiatriques ou l'effet d'une substance ou d'autres pathologies mentales. La présence d'obsession et de compulsion, la gêne considérable et la perte de temps. Pour le diagnostic différentiel, il faut distinguer les obsessions et les compulsions de ce qu'on peut appeler l'obsession normale.

80 à 100 % des gens, à un moment donné, peuvent avoir une idée qui a ce caractère un peu intrusif et obsédant, mais ça reste momentanée, ça reste passagère, ça ne crée pas d'anxiété. Je pense que vous tous, par moment, vous vous trouvez en train de répéter, par exemple, un morceau d'une chanson, pas forcément une chanson qui vous plaît, mais peut-être que vous l'avez écoutée dans les jours précédents, dans un café ou dans un taxi, sans se rendre compte. Vous vous trouvez en train de répéter un petit morceau de cette chanson, mais vous arrivez facilement à s'en débarrasser quand vous voulez faire autre chose.

Pareil, par exemple, quand on est dans une salle d'attente, ça nous arrive parfois à commencer à compter les angles des fenêtres ou le nombre de vitres, mais ça reste passagère, ça ne génère pas de l'anxiété et ça peut se voir chez toute la population. Pour le mentisme, ça correspond à un défilé rapide et incoercible, incontrôlable que d'images ou de pensées qui se voient souvent à un moment de l'endormissement, chez des personnes dans des périodes de forte angoisse, d'anxiété. Au moment de l'endormissement, des images et des pensées peuvent défiler de façon très rapide et incontrôlable, incoercible, dont le contenu peut être angoissant, ça peut générer des troubles du sommeil, mais ça reste très ponctuel dans les moments d'anxiété.

Le trouble obsédé général confusif, bien sûr, a différencié aussi de certains troubles anxieux. Pour les phobies, on a vu la différence. La phobie, c'est avec l'exposition à l'objet ou à la situation phobogène.

Par contre, dans le TOC, c'est une crainte qui est obsédée, qui est répétitive même en l'absence d'une exposition à cet objet. Pour le TAG, le trouble d'anxiété généralisé qu'on a vu, il y a aussi ces soucis permanents répétés que la personne présente, mais comme on a vu, ce sont des soucis qui sont en rapport avec les soucis de la vie quotidienne. Ça va dans le même sens que les préoccupations de la personne.

Une personne qui craint pour la santé de ses enfants va avoir des soucis par rapport à la santé de ses enfants. Ces soucis n'ont pas le caractère absurde ou égo-dystonique, on parle dans le TAG d'égo-symptomatique. Ce sont des soucis qui sont en rapport avec ce que la personne pense réellement.

Pour l'hypochondrie, c'est une autre pathologie, un autre problème psychiatrique où la personne est convaincue d'avoir une maladie. Ce n'est pas la peur d'avoir une maladie comme dans l'obsession. Là, c'est une personne qui va être convaincue d'avoir réellement une maladie.

Elle va entamer plusieurs consultations chez plusieurs médecins et même avec tous les examens qui vont revenir normaux. Quand elle sera assurée par le médecin, la personne va avoir toujours ce doute et cette conviction d'être malade et va multiplier les consultations et voir plusieurs médecins. A différencier aussi de ce qu'on appelle les apparentés du trouble qui sont regroupées dans le même chapitre avec le trouble obsessionnel compulsif dans le DSM et aussi

dans la CM11, qui sont d'autres pathologies qui ressemblent un petit peu au trouble obsessionnel compulsif parce qu'il y a aussi cette composante compulsive obsédante.

D'abord, l'obsession d'une dysmorphie corporelle. C'est l'idée obsédante chez certaines personnes qui ont un défaut physique. Des fois, ce défaut est tellement minime, invisible ou très peu gênant pour la majorité des gens.

Pour ces gens-là, ils vont rester totalement fixés sur ce défaut minime et avec une idée obsédante qui revient par rapport à des préoccupations par rapport à ce défaut. Donc, ça se limite à ce défaut physique. Pour la syllogomanie, c'est un autre trouble.

Avant, on appelait ça des collectionnismes. Ce sont des personnes qui vont collectionner des objets sans valeur. Ils ont du mal à se séparer de leurs objets.

Donc, ils vont garder tout chez eux. Des fois, jusqu'à l'encombrement. Des fois, leur maison ou leur espace privé est tellement encombré, tellement rempli d'objets sans valeur qu'ils ont du mal à les jeter ou à s'en séparer.

Ça peut être des journaux anciens, ça peut être n'importe quoi, mais ce sont des gens qui n'arrivent pas à se séparer de leurs objets. La tricotillomanie, c'est appelé aussi arrachage compulsif des cheveux. Donc, ce sont des gens qui ont un comportement compulsif d'arrachage des cheveux, des fois avec même des dégâts, des plaques d'alopecies.

Pour la dermatillomanie, ce sont aussi des comportements compulsifs de trituration de la peau. Donc, ce sont des gens qui vont triturer de façon compulsive leur peau et provoquer des lésions graves au niveau de leur peau. Mais, ils n'arrivent pas à s'empêcher de le faire.

Généralement, c'est généré par une anxiété antérieure. Le terme aussi est à différencier de l'idée délirante. L'idée délirante, c'est surtout des hallucinations très psychiques ou auditives qui sont des hallucinations, des perceptions sans objet à percevoir qui sont imposées par l'extérieur.

Et aussi, l'idée délirante, par exemple, dans l'idée de jalousie. Je ne sais pas s'il voudrait traiter les délires chroniques non schizophréniques. Pas encore.

La paranoïa, l'ancien paranoïa. Un des types de la paranoïa, c'est le paranoïa passionnel, le délire de jalousie, où la personne est convaincue de l'infidélité de son partenaire ou de son conjoint. Donc, là, c'est une idée obsédante qui va s'imposer à la personne comme quoi son conjoint le trompe ou a des rapports.

Mais la personne sait que son conjoint ou sa partenaire n'est pas infidèle. Mais l'idée est tellement présente qu'elle va créer de l'anxiété. Dans le délire passionnel, la personne est convaincue.

Elle est convaincue que le conjoint ou la partenaire est infidèle. Elle est en train de rassembler

les preuves et ça risque de passer à l'acte par des homicides ou des actes hétéroagressifs. Et puis dernièrement, la dépression, notamment dans les formes mélancoliques, les formes graves, mélancoliques, où on peut avoir un certain mono-idéalisme, des idées de culpabilité ou de faute ou d'incurabilité.

Je pense que vous avez traité, mais ça rentre dans le cadre global d'une dépression avec les symptômes dépressifs, de la tristesse et de l'anidonie et le reste des symptômes. Pour l'éthiopathogénie, juste à titre d'information, comme pour la plupart des pathologies psychiatriques, c'est un modèle qui regroupe aussi bien des facteurs biologiques, génétiques et anatomiques et neurobiologiques et des facteurs psychologiques ou environnementaux. Pour les modèles biologiques, on a l'hypothèse génétique parce qu'effectivement il y a certaines familles où le nombre de cas de TOC est assez élevé, 55 fois si on a un parent de premier degré atteint de TOC.

Il y a aussi une hypothèse neuroanatomique par rapport à l'hyperfonctionnement de certaines régions cérébrales qui sont responsables de certaines actions, comme les tâches de programmation, de vérification et d'inhibition comportementale, comme les régions orbitofrontales et les noyaux codés. Chez les gens présentant le TOC, on a remarqué qu'il y a une hyperactivité de ces régions dans les imageries fonctionnelles. Et puis aussi, toujours dans l'hypothèse biologique, la neurobiologie, c'est le dysfonctionnement des monoamines cérébrales, des neurotransmetteurs, la sérotonine, la noradrénaline et surtout l'hyperactivité dopaminergique.

Mais aussi même l'axe hypothalamo-hypophysosurénalien pourrait être incriminé. Pour les modèles psychologiques, comportementaux et cognitifs, on suggère qu'il y a chez ces personnes-là une certaine hypersensibilité, une activation émotionnelle qui est anormalement élevée et que la personne est tellement hypersensible à des stimuli externes qui sont neutres et qui peut associer cette hyperactivation à ces stimuli et qui devient par la suite source d'idées obsédantes. Mais aussi par rapport à des schémas inconscients, des schémas de pensée qui sont des fois liés à des interprétations catastrophiques où il y a cette notion de responsabilité de l'individu qu'on a vu précédemment.

Pour l'évolution du trouble, souvent c'est un trouble chronique, c'est parmi les troubles qu'on a du mal à gérer, à prendre en charge, c'est parmi les troubles les plus difficiles à prendre en charge. Généralement, c'est une évolution fluctuante, des périodes où les choses s'atténuent et des moments où les symptômes s'aggravent et deviennent très gênants. C'est un trouble qui expose bien sûr, du fait de cette gêne importante, de cette anxiété importante, c'est un trouble qui expose à beaucoup de complications, notamment des complications dépressives, qui des dépressions liées à l'épuisement, dit risque suicidaire aussi.

C'est aussi le risque d'abus, d'utilisation de substances illicites comme l'alcool ou le cannabis. Ça peut aussi retentir sur le plan familial, comme on l'a cité, sur le plan professionnel, le patient qui pensait ou qui avait cette image de son épouse dans les bras d'un autre homme, finalement, les

procédures de divorce étaient en cours parce que cette image était tant présente qu'il commençait à interroger son épouse. De là, les problèmes conjugaux se sont déclenchés et se sont aggravés.

C'est parmi les conséquences familiales et du trouble obsessionnel compulsif. On arrive au chapitre du traitement. Pour le traitement du trouble obsessionnel compulsif, c'est un traitement qui offre plusieurs choix thérapeutiques.

D'abord, le traitement pharmacologique ou médicamenteux se base essentiellement sur les antidépresseurs qui sont le traitement de fond du trouble obsessionnel compulsif. Les antidépresseurs de deuxième génération sont donnés en première intention, notamment les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la serotonine. C'est un trouble qui nécessite souvent des doses très élevées.

C'est là où on arrive aux doses maximales des antidépresseurs dans le trouble obsessionnel compulsif. Pour beaucoup de patients, on est amené à donner des doses très élevées pour pouvoir gérer le trouble. C'est aussi un délai d'action plus long par rapport aux autres troubles.

Il peut aller jusqu'à trois mois et une durée de traitement globale qui est aussi très importante. On peut garder la dose initiale ou la double dose, la dose de charge, au moins six mois et ne revenir à des doses d'entretien qu'après atténuation des symptômes. Pour la durée du traitement, ça peut aller jusqu'à deux ans et même plusieurs années si le trouble n'est pas réglé à 100%.

Les IRS sont en première intention. On a plusieurs choix. Pour les molécules que l'on a vues la dernière fois, il y a une nouvelle molécule qui est la fluoxétine qui est plutôt excitatrice par rapport aux autres.

On évite de donner dans les autres troubles anxieux pour ne pas accentuer cette anxiété. Là, c'est une molécule qui a donné ses preuves aussi dans le trouble obsessionnel compulsif et toujours de deux à quatre gélules par jour alors que la dose habituelle c'est un comprimé ou une gélule par jour. Comme vous le voyez, pour les différentes molécules, on peut aller jusqu'à la dose maximale.

Il y a aussi la clomipramine, l'anafranil, qui fait partie des antidépresseurs d'ancienne génération, des tricycliques, qui a longtemps aussi fait sa preuve dans le trouble obsessionnel compulsif et qui reste un traitement de référence. Mais bien sûr, on peut peut-être y penser si on n'arrive pas à traiter par les nouvelles générations qui donnent moins d'effets secondaires. Mais là aussi, même pour la clomipramine, la dose habituelle c'est 75mg, mais là aussi on peut aller jusqu'à la dose maximale.

Pour le traitement de fond, c'est les antidépresseurs. Pour les autres traitements, ce sont des traitements adjuvants qui vont aider les antidépresseurs. Il y a les benzodiazépines comme anxiolytiques qui peuvent être intéressants pour atténuer de façon ponctuelle, de façon de durée,

limiter l'anxiété le temps que l'antidépresseur fasse effet.

Ça doit être une prescription de courte durée pour ne pas exposer la personne au problème de dépendance et de sevrage. Il y a aussi les antipsychotiques. Les antipsychotiques qui sont généralement des traitements adressés pour les troubles psychotiques comme l'accès psychotique, la schizophrénie, la paranoïa, le trouble schizoaffectif.

Là, on est amené parfois à ajouter de faibles doses d'antipsychotiques justement pour potentialiser l'effet d'antidépresseur. Ça témoigne aussi de la difficulté de prise en charge du trouble obsessionnel complexif. Mais ça reste des posologies minimales.

On n'arrive pas à aller aux mêmes doses que dans les pathologies psychotiques, mais c'est juste des petites doses comme 2,5 ou 5 mg d'olanzapine pour aider. C'est des traitements qui peuvent être maintenus pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Pour ce qui est du traitement psychothérapique, ça se base essentiellement sur les thérapies cognitives et comportementales.

Les thérapies comportementales utilisent une technique spécifique pour le trouble obsessionnel complexif qu'on appelle exposition avec prévention de la réponse ritualisée. C'est une technique qui va aider le patient à s'exposer ou à être confronté à la source de ses obsessions, par exemple de toucher quelque chose qui d'habitude a du mal à toucher par peur de suivre de contamination. Mais ça se fait de façon très progressive, très graduelle en présence au départ du thérapeute et le thérapeute va aider le patient à gérer son anxiété sans recourir au comportement compulsif qui suit l'idée obsédante.

Ça se fait bien sûr sur plusieurs séances et on demande aussi au patient de faire quelques tâches à domicile pour continuer les exercices. Pour la thérapie cognitive, c'est bien sûr d'essayer d'identifier ces schémas cognitifs qui sont un peu dysfonctionnels et essayer de les assouplir et préparer la personne aux séances comportementales. À côté du traitement pharmacologique et psychothérapeutique, pour le TOC, certains pays ou certains auteurs proposent même un traitement chirurgical, neurochirurgical.

C'est-à-dire que c'est un trouble qui pose des difficultés sur le plan prise en charge. Pour certains pays, on propose des techniques neurochirurgicales comme une chirurgie stéréotaxique. On vise de façon très précise les régions hyperactives ou parfois on utilise du galvanisme ou de la stimulation cérébrale profonde comme dans la pathologie par exemple parkinsonienne.

Mais ce sont des techniques de pointe réservées aux cas très difficiles avec un échec de tous les moyens thérapeutiques et ça reste un certain pays. Voilà pour conclure. C'est une pathologie assez fréquente qui est très gênante voire parfois très invalidante.

Il faut rechercher de façon active le rôle du médecin primordial dans le dépistage, dans la prise en charge initiale et dans l'orientation pour les cas qui nécessitent une prise en charge spécialisée. Voilà pour le premier cours. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au

premier chapitre.